

Escalas de Contenido y Suplementarias

Escalas de contenido

1. Escalas de contenido que evalúan síntomas

Las escalas que conforman este grupo (ANX, FRS, OBS, DEP, HEA y BIZ) evalúan síntomas y cogniciones desadaptativas que un sujeto puede presentar. Las puntuaciones elevadas en estas escalas brindan indicios acerca de conductas sintomáticas singulares, creencias cognitivas desviadas o poco adaptativas y disturbios en el pensamiento.

- Escala ANX (Ansiedad)

- Contenido

Los 23 ítems que forman la escala tratan sobre la presencia de problemas de ansiedad generalizada. Sus ítems abarcan síntomas como tensión, problemas somáticos (por ejemplo: dificultad para respirar, taquicardia), dificultades de sueño, preocupaciones excesivas y problemas de concentración. Los sujetos que obtienen altas puntuaciones suelen referir sensación de pérdida de control sobre su mente, experimentan la vida en términos de tensión y tienen dificultades para tomar decisiones. En general, se trata de personas que reconocen y admiten sus síntomas y problemas.

- Guía para la interpretación de los puntajes

- T > 65: puntaje elevado. Los puntajes elevados indican que el sujeto reconoció la mayoría de los síntomas de ansiedad incluidos en esta escala.

- T 60 a 64: puntaje moderadamente elevado. Estas puntuaciones indican que el sujeto reconoció varios de los síntomas de ansiedad incluidos en esta escala.

- Resumen de descriptores para los puntajes elevados

- síntomas de ansiedad, preocupación y tensión
- problemas somáticos, en especial taquicardia y disnea
- dificultades de sueño
- dificultades para tomar decisiones
- dificultades de concentración
- temor de perder el control sobre la mente
- indecisión
- experimentan la vida como fuente de tensión
- reconocen y admiten problemas y síntomas ansiosos

- Escala FRS (Miedos)

- Contenido

Los 23 ítems que conforman la escala versan acerca de fobias o miedos específicos. Los sujetos que obtienen puntuaciones elevadas en esta escala manifiestan un número inusual de miedos o fobias a diferentes situaciones o cosas. La escala incluye ítems acerca del temor a los lugares abiertos, a manejar dinero, a ciertos animales (arañas, reptiles, etc.), al fuego, a los desastres naturales, al agua, a la oscuridad, a la suciedad, a quedar encerrado y a ver sangre. Si bien la fobia es considerado un trastorno que se incluye dentro de los de ansiedad, la escala no evalúa síntomas de ansiedad generalizada como sucede en ANX.

- Guía para la interpretación de los puntajes elevados

- T > 65: puntaje elevado. Los puntajes elevados indican que el sujeto reconoció la mayoría de los síntomas de miedos o fobias incluidos en esta escala.

- T 60 a 64: puntaje moderadamente elevado. Estas puntuaciones indican que el sujeto reconoció varios de los síntomas de miedos o fobias incluidos en esta escala.

- Resumen de descriptores para los puntajes elevados

- reconocimiento de experimentar temor a situaciones y/
o a objetos específicos (sangre, lugares abiertos, lugares cerrados, animales, dinero, fuego, agua, tormentas, desastres naturales, oscuridad, dejar el hogar, suciedad).

- Escala OBS (Obsesiones)

- Contenido

Los 16 ítems de la escala tratan acerca de procesos cognitivos poco adaptativos tales como rumiación y pensamientos obsesivos. Los sujetos con puntajes altos en esta escala tienen

dificultades severas para tomar decisiones y tienden a pensar una y otra vez los problemas o las situaciones por los que atraviesan, por mínimos que éstos sean. Esta actitud, por lo general, provoca impaciencia en quienes le rodean. Los cambios son, para estos sujetos, fuente de estrés y tensión. Es probable que presenten conductas compulsivas tales como contar cosas o lavarse las manos repetidamente y, en general, son muy ahorrativos. Se preocupan en demasía y, con frecuencia, se sienten abrumados por sus propios pensamientos. Parecen ser poco capaces de funcionar de modo práctico.

— Guía para la interpretación de los puntajes elevados

- T > 65: puntaje elevado. Los puntajes elevados indican que el sujeto reconoció la mayoría de los síntomas de obsesión incluidos en esta escala.

- T 60 a 64: puntaje moderadamente elevado. Estas puntuaciones indican que el sujeto reconoció varios de los síntomas de obsesión incluidos en esta escala.

— Resumen de descriptores para los puntajes elevados

- dificultades severas para tomar decisiones
- rumiación excesiva acerca de sus problemas o situaciones
- temor de provocar impaciencia en los demás
- tendencia al estrés ante situaciones de cambio
- conductas compulsivas
- preocupación excesiva
- sensación de estar sumergido y abrumado por sus propios pensamientos

• Escala DEP (Depresión)

— Contenido

La escala está compuesta por 33 ítems que evalúan sintomatología depresiva. Los sujetos que puntúan elevado se caracterizan por tener pensamientos depresivos en forma significativa. Pueden referir melancolía, incertidumbre y desinterés hacia sus vidas, y presentar cavilación; infelicidad, desesperanza acerca del futuro y crisis de llanto. Es frecuente que se sientan vacíos y pueden aparecer pensamientos de suicidio o deseos de estar muertos. Muchas veces se observa en estos sujetos la creencia de que están condenados o que cometieron pecados imperdonables. Tienden a considerar a los demás como poco contenedores.

— Guía para la interpretación de los puntajes elevados

- T > 65: puntaje elevado. Los puntajes elevados indican que el sujeto reconoció la mayoría de los síntomas de depresión incluidos en esta escala.

- T 60 a 64: puntaje moderadamente elevado. Estas puntuaciones indican que el sujeto reconoció varios de los síntomas de depresión incluidos en esta escala.

— Resumen de descriptores para los puntajes elevados

- pensamientos depresivos
- sentimientos de melancolía e incertidumbre acerca del futuro
- desinterés acerca de sus vidas
- escasos intereses
- desesperanza y sensación de vacío
- cavilación, infelicidad, crisis de llanto
- probabilidad de ideación suicida, deseos de estar muertos
- creencias de condenación y culpa

• Escala HEA (Preocupaciones por el estado de salud)

- Contenido

La escala está formada por 36 ítems que evalúan preocupaciones por la salud y síntomas físicos. Los sujetos con puntuaciones elevadas se caracterizan por presentar muchos síntomas de diferentes orígenes (gastrointestinales, cardiovasculares, respiratorios, neurológicos, sensoriales) y preocupaciones por el estado de salud en una proporción mayor que la del promedio. Es frecuente que el examen médico no provea base orgánica a estos síntomas.

— Guía para la interpretación de los puntajes elevados

- T > 65: puntaje elevado. Los puntajes elevados indican que el sujeto reconoció la mayoría de los síntomas y preocupaciones incluidos en esta escala.

- T 60 a 64: puntaje moderadamente elevado. Estas puntuaciones indican que el sujeto reconoció varios de los síntomas y las preocupaciones incluidos en esta escala.

— Resumen de descriptores para los puntajes elevados

- reconocimiento de síntomas variados en diferentes sistemas del cuerpo
- preocupaciones acerca del estado de salud

- sensación más o menos constante de padecer alguna enfermedad

- Escala BIZ (Pensamiento bizarro)

- Contenido

La escala está formada por 24 ítems que evalúan desórdenes del pensamiento. Los puntajes elevados son característicos en sujetos que señalaron ítems que indican procesos de pensamiento psicóticos. Pueden referir alucinaciones visuales, auditivas u olfatorias, y reconocer poseer pensamientos extraños y peculiares. También es frecuente que presenten ideación paranoide y la sensación de que tienen una misión especial o poderes sobre los demás. Las elevaciones mayores de T 65 indican la presencia de problemas de pensamiento de forma significativa e inusual.

- Guía para la interpretación de los puntajes elevados

- T > 65: puntaje elevado. Los puntajes elevados indican que el sujeto reconoció la mayoría de los síntomas de desorden del pensamiento incluidos en esta escala.

- T 60 a 64: puntaje moderadamente elevado. Estas puntuaciones indican que el sujeto reconoció varios de los síntomas de desorden del pensamiento incluidos en esta escala.

- Resumen de descriptores para los puntajes elevados

- probabilidad de alucinaciones visuales, olfativas o auditivas
- reconocimiento de que sus pensamientos son extraños y peculiares
- ideación paranoide
- sensación de tener una misión o poderes especiales

2. Escalas que evalúan tendencias agresivas

Las cuatro escalas de este cluster (ANG, CYN, ASP y TPA) brindan información acerca de la expresión externa de las emociones y del control de la conducta. Los puntajes de estas escalas indican cómo el sujeto trata con los demás. Cuando la puntuación es significativa sugiere que el individuo presenta actitudes desadaptadas en la relación con las demandas de su situación vital.

- Escala ANG (Hostilidad)

- Contenido

Esta escala, compuesta por 16 ítems, evalúa la pérdida de control en situaciones de ira o enojo. Los sujetos con puntajes elevados presentan, en general, problemas de control de la hostilidad. Suelen referir ser irritables, impacientes, malhumorados, exaltados, fastidiosos y testarudos. En ocasiones, se sienten renegados o quebrados. Pueden perder el autocontrol y cometer actos de abuso físico sobre personas y objetos.

- Guía para la interpretación de los puntajes elevados

- T > 65: puntaje elevado. Los puntajes elevados indican que el sujeto reconoció la mayoría de los problemas de control de la hostilidad incluidos en esta escala.

- T 60 a 64: puntaje moderadamente elevado. Estas puntuaciones indican que el sujeto reconoció varios de los problemas de control de la hostilidad incluidos en esta escala.

- Resumen de descriptores para los puntajes elevados

- problemas de control de la hostilidad
- irritabilidad, malhumor e impaciencia
- exaltación, fastidio, terquedad
- sentimientos ocasionales de ruina o de ser renegados
- preocupaciones por la pérdida de control
- probabilidad de actos de abuso físico hacia personas y/u objetos

- Escala CYN (Cinismo)

- Contenido

La escala está formada por 23 ítems que evalúan creencias cínicas y actitudes misantrópicas. Veinte de ellos fueron seleccionados a través de un análisis factorial de ítems por Johnson y cols. (1984). Los tres restantes fueron agregados para el MMPI-2 y también fueron seleccionados por análisis de ítems. Los sujetos con puntajes elevados en esta escala poseen actitudes negativas hacia los demás y suelen esperar que éstos actúen por motivos oscuros y secretos. Por ejemplo, creen que la mayoría de las personas son amistosas en la medida que obtienen algún beneficio de ello, o que son honestas porque temen enfrentarse con la ley. Los puntajes altos indican actitudes negativas aun hacia personas cercanas (familiares, compañeros de trabajo y amigos).

- Guía para la interpretación de los puntajes elevados
 - T > 65: puntaje elevado. Los puntajes elevados indican que el sujeto reconoció la mayoría de los comportamientos y las actitudes cínicas incluidos en esta escala.
 - T 60 a 64: puntaje moderadamente elevado. Estas puntuaciones indican que el sujeto reconoció varios de los comportamientos y las actitudes cínicas incluidos en esta escala.
- Resumen de descriptores para los puntajes elevados
 - creencias y actitudes misantrópicas
 - expectativa de que los demás actúan con motivaciones negativas y secretas
 - desconfianza acerca de los otros
 - creencia de que los demás son amistosos de un modo interesado
 - actitudes negativas hacia el entorno más cercano
- Escala ASP (Prácticas antisociales)
 - Contenido

Esta escala está compuesta por 22 ítems que evalúan características de personalidad antisocial. Las puntuaciones elevadas indican actitudes misantrópicas, problemas de comportamiento en los años escolares, problemas con la ley, probabilidad de haber cometido hurtos, entre otros. Las personas con este tipo de puntajes en la escala ASP suelen admitir que se divierten con las extravagancias de ciertos delincuentes y no creen que sea incorrecto bordear los límites de la ley con ciertos actos o conductas.
 - Guía para la interpretación de los puntajes elevados
 - T > 65: puntaje elevado. Los puntajes elevados indican que el sujeto reconoció la mayoría de los comportamientos y las actitudes antisociales incluidos en esta escala.
 - T 60 a 64: puntaje moderadamente elevado. Estas puntuaciones indican que el sujeto reconoció varios de los comportamientos y las actitudes antisociales incluidos en esta escala.
 - Resumen de descriptores para los puntajes elevados
 - actitudes misantrópicas similares a las de CYN
 - problemas de conducta en la época escolar
 - prácticas antisociales que pueden incluir problemas con la ley y actos delictivos
 - consideración de que es correcto actuar al límite de lo legal
 - interés por las conductas peculiares de algunos criminales

- Escala TPA (Comportamiento tipo A)
 - Contenido

Los 19 ítems de la escala, la mayoría de los cuales fueron formulados para la versión MMPI-2, evalúan un estilo de personalidad caracterizado por impulsividad, hostilidad y competitividad. Las puntuaciones elevadas señalan a personas inquietas, orientadas hacia el trabajo y resolutivas. Con frecuencia se trata de sujetos impacientes e irritables que se molestan en exceso si son interrumpidos. Les suele disgustar el tener que esperar o que se dilaten las tareas que tienen entre manos. Refieren que nunca disponen del tiempo suficiente como para concluir sus compromisos. Tienden a ser directos y dominantes en sus relaciones con los demás. En general, son vistos por los otros como agresivos, despóticos y con mezquindad acerca de detalles menores.
 - Guía para la interpretación de los puntajes elevados
 - T > 65: Los puntajes elevados indican que el sujeto reconoció la mayoría de los comportamientos y las actitudes incluidos en esta escala.
 - T 60 a 64: puntaje moderadamente elevado. Estas puntuaciones indican que el sujeto reconoció varios de los comportamientos y las actitudes incluidos en esta escala.
 - Resumen de descriptores para los puntajes elevados
 - inquietud, aceleramiento
 - impaciencia, irritabilidad
 - orientación intensa hacia el trabajo
 - sensación de carecer de tiempo suficiente para realizar sus tareas
 - tienden a asumir una posición dominante respecto de los demás

3. Evaluación de la autoestima negativa

- Escala LSE (Baja autoestima)
 - Contenido

La escala LSE está formada por 24 ítems y fue diseñada con el objeto de proporcionar una medida que indicara la actitud negativa hacia el sí mismo y que no se solapara con aspectos sintomáticos. Las personas que puntúan elevado en esta escala tienden a percibirse en términos negativos y tienen opiniones pobres acerca de ellas mismas. No consideran ser importantes ni agradables para los demás y, es probable, que se vean a sí mismas como personas poco atractivas y desmañadas que representan una carga para los demás. Pueden referir baja autoconfianza y ser reacias a aceptar cumplidos. Es probable que se sientan agobiadas por las muchas faltas que ven en sí mismas.

— Guía para la interpretación de los puntajes elevados

- T > 65: puntaje elevado. Los puntajes elevados indican que el sujeto reconoció la mayoría de los comportamientos y las actitudes incluidos en esta escala.

- T 60 a 64: puntaje moderadamente elevado. Estas puntuaciones indican que el sujeto reconoció varios de los comportamientos y las actitudes incluidos en esta escala.

— Resumen de descriptores para los puntajes elevados

- pobreza en la opinión de sí mismo
- percepción de resultar poco atractivo para los demás
- sensación de timidez
- sensación de torpeza, de inutilidad
- falta de autoconfianza
- agobio, dificultad para aceptar opiniones favorables

4. Escalas que evalúan áreas de problemas

Las escalas incluidas en este conjunto (SOD, FAM, WRK, TRT) son más complejas que las anteriores, ya que no tratan solamente de evaluar rasgos o actitudes como las anteriores, sino que abarcan áreas de problemas. Estas escalas proporcionan información acerca de problemas en las relaciones sociales, percepciones y preocupaciones familiares, actitudes y actividades laborales desajustadas y pueden servir de guía para valorar en qué medida las características de personalidad pueden o no interferir en un tratamiento psicológico futuro.

• Escala SOD (Malestar social)

— Contenido

Los 24 ítems de la escala evalúan la incomodidad en situaciones sociales. Los aumentos en la puntuación indican sujetos que prefieren estar solos en lugar de estar con otros, y que, si se ven obligados a asistir a reuniones, lo hacen permaneciendo apartados del resto del grupo. Pueden ser tímidos y preferir las actividades solitarias a las mundanas.

— Guía para la interpretación de los puntajes elevados

- T > 65: puntaje elevado. Los puntajes elevados indican que el sujeto reconoció la mayoría de los comportamientos y las actitudes incluidos en esta escala.

- T 60 a 64: puntaje moderadamente elevado. Estas puntuaciones indican que el sujeto reconoció varios de los comportamientos y las actitudes incluidos en esta escala.

— Resumen de descriptores para los puntajes elevados

- introversión, distancia social
- incomodidad en situaciones sociales
- preferencia por la soledad
- timidez

• Escala FAM (Problemas familiares)

- Contenido

La escala FAM valora, a través de sus 25 ítems, los problemas en las relaciones familiares. Una puntuación elevada en la escala se relaciona con experiencias de discordia familiar. Puede indicar a sujetos que describen a sus familias como desamoradas y proclives a las disputas, y que albergan sentimientos de odio hacia algún miembro de ellas. Es frecuente que refieran antecedentes de una infancia con episodios de algún tipo de abuso y que sus vínculos maritales actuales sean descritos como infelices y faltos de afecto.

— Guía para la interpretación de los puntajes elevados

- T > 65: puntaje elevado. Los puntajes elevados indican que el sujeto reconoció la mayoría de los comportamientos y las actitudes incluidos en esta escala.

- T 60 a 64: puntaje moderadamente elevado. Estas puntuaciones indican que el sujeto reconoció varios de los comportamientos y las actitudes incluidos en esta escala.

— Resumen de descriptores para los puntajes elevados

- discordia familiar
- familias desamoradas, pendencieras
- probabilidad de sentimientos negativos hacia algún familiar
- probabilidad de antecedentes infantiles de abuso
- probabilidad de matrimonios o uniones infelices

- Escala WRK (Interferencias laborales)

- Contenido

La escala WRK contiene 33 ítems que evalúan actitudes negativas y problemas hacia y en el desempeño laboral. Los aumentos se asocian con probables actitudes o problemas personales que pueden interferir en el ámbito laboral y afectar el rendimiento en el área. Algunos de los problemas relacionados pueden ser de baja autoestima, dificultades de concentración, minuciosidad, tensión e indecisión. Otros, en cambio, sugieren la presencia de falta de soporte familiar para la carrera de su elección, cuestionamientos vocacionales y actitudes negativas hacia sus compañeros de trabajo.

- Guía para la interpretación de los puntajes elevados

- T > 65: puntaje elevado. Los puntajes elevados indican que el sujeto reconoció la mayoría de los comportamientos y las actitudes incluidos en esta escala.
- T 60 a 64: puntaje moderadamente elevado. Estas puntuaciones indican que el sujeto reconoció varios de los comportamientos y las actitudes incluidos en esta escala.

- Resumen de descriptores para los puntajes elevados

- actitudes y/o comportamientos que contribuyen a un clima laboral negativo
- baja autoconfianza
- dificultades de concentración, obsesividad, tensión
- dificultades para tomar la iniciativa
- ante el aumento de dificultades, darse por vencido rápidamente
- problemas para la toma de decisiones
- falta de soporte familiar respecto de la elección de su carrera
- preocupaciones personales acerca de las propias elecciones
- actitudes negativas hacia pares y superiores

- Escala TRT (Indicadores negativos hacia el tratamiento)

- Contenido

Los 26 ítems de la escala ponderan las actitudes y los problemas para aceptar ayuda o para producir cambios de conducta. Las personas que obtienen puntuaciones elevadas en TRT se caracterizan por poseer actitudes negativas hacia los clínicos y hacia el tratamiento. Se trata, en general, de sujetos que consideran muy poco probable que alguien los comprenda o ayude. Tienen conciencia de presentar dificultades pero, con frecuencia, se sienten incómodos al hablar de ellas. Pueden presentar escaso interés en cambiar algo en sus vidas y sentir que el cambio actual no es posible. Se desalientan con facilidad ante las crisis o las dificultades.

- Guía para la interpretación de los puntajes elevados

- T > 65: puntaje elevado. Los puntajes elevados indican que el sujeto reconoció la mayoría de los comportamientos y las actitudes incluidos en esta escala.
- T 60 a 64: puntaje moderadamente elevado. Estas puntuaciones indican que el sujeto reconoció varios de los comportamientos y las actitudes incluidos en esta escala.

- Resumen de descriptores para los puntajes elevados

- actitudes negativas hacia los profesionales de salud mental
- sensación de que nadie puede ayudarlos ni comprenderlos
- dificultad para hablar de sus problemas
- sensación de no necesitar cambios en sus vidas
- creencia de que el cambio actual no es posible
- al encarar crisis o dificultades, darse por vencidos fácilmente

B. Escalas suplementarias

Las escalas suplementarias fueron construidas para enriquecer la interpretación de las escalas básicas y aumentar así el espectro de problemas y desórdenes clínicos que abarcan

aquellas. En la interpretación de estas escalas no pueden ser especificadas, con rigor, las diferencias entre altos y bajos puntajes. Según Butcher y coautores (1989):

36) pueden ser considerados significativos aquellos puntajes que sobrepasan el T 65 y, en algunos casos, los menores de T 40.

En este apartado se proveerá información acerca de las escalas suplementarias de mayor uso clínico. Se basará en *Essentials of MMPI-2 and MMPI-A Interpretation*, de Butcher y Williams (1995), *MMPI-2: Manual for Administration and Scoring*, de Butcher, Dahlstrom, Graham, Tellegen y Kaemmer (1989), y en diversos artículos de varias revistas especializadas.

- Escala: MAC-R (Escala revisada de alcoholismo de MacAndrew)

Esta escala fue diseñada por MacAndrew (1965) contrastando las respuestas dadas por dos grupos diferentes de pacientes: un grupo de sujetos con antecedentes de alcoholismo y, otro, de pacientes psiquiátricos sin historia de consumo de alcohol. La escala MAC-R del MMPI-2 mantiene los 49 ítems anteriores pero cuatro de ellos, de contenido religioso, fueron reemplazados por otros tantos que están asociados con el abuso de alcohol y con el de drogas.

Las investigaciones realizadas en base a la escala sugieren que los puntajes elevados pueden ser asociados con una tendencia general a las adicciones más que con la predisposición al abuso de alcohol particularmente.

En la versión original se consideraba un puntaje de corte de 24 para hombres y de 22 para mujeres. Sin embargo, los profesionales, notaron que los puntajes de 26 para los primeros y de 24 para las segundas discriminaban mejor que los anteriores. La investigación empírica señala que la escala MAC-R se muestra eficaz para evaluar los problemas de adicción (Graham y Strenger, 1988) y que resulta menos efectiva si los puntajes de corte utilizados son los más bajos (Gottesman y Prescott, 1989). Además, Graham y Strenger notaron que la escala no es útil para diferenciar entre abuso de alcohol o de drogas. Es, por lo tanto, una indicación de la predisposición o tendencia a las adicciones más que una escala de abuso de alcohol o drogas específica. Graham (1989), en ocasión del estudio de re-estandarización, encontró que puntajes MAC-R significativos se asociaban a los siguientes problemas:

Para hombres: de acuerdo con la visión de sus cónyuges fueron descritos como imprecadores, bebedores excesivos de alcohol, consumidores ocasionales de drogas no prescritas, mentirosos, intrépidos, orientados a la acción, con juicio a veces inapropiado y que habían sido arrestados o que habían tenido problemas con la ley.

Para mujeres: las mujeres que puntuaron alto en la escala fueron descritas por sus esposos como bebedoras excesivas de alcohol, de conductas riesgosas, extravertidas, sin demasiado cuidado en cuestiones afectivas y que habían tenido problemas con la ley.

— Guía para la interpretación de los puntajes

- T 65 o >: el puntaje sugiere enfáticamente la presencia de un estilo de vida asociado con la aparición de desórdenes por adicciones.

- T 60-64: el puntaje señala la probabilidad de características relacionadas con el abuso de drogas o de alcohol,

- Los puntajes bajos (59 o <) no invalidan necesariamente la presencia de problemas de abuso de sustancias. En general, este tipo de puntajes puede señalar la probabilidad de abuso basado en una historia de desajuste psicológico más que en un patrón típico de conducta adictiva.

- Escala: APS (de potencial de adicción)

La escala de Adicción Potencial fue desarrollada para evaluar los factores de personalidad característicos de aquellos que presentan desórdenes por adicciones (Weed y cols., 1992). La escala fue derivada empíricamente al seleccionar los ítems que diferenciaron entre consumidores de alcohol y drogas, pacientes psiquiátricos y sujetos normales. Consta de 39 ítems, de los cuales nueve se solapan con los de la escala MAC-R. La interpretación, por lo tanto, se asemeja a la de esta última.

— Guía para la interpretación de los puntajes

- T 65 o >: el puntaje sugiere enfáticamente la presencia de un estilo de vida asociado con la aparición de desórdenes por adicciones.

- T 60-64: el puntaje señala la probabilidad de características relacionadas con el abuso de drogas o de alcohol.

- En la actualidad, la escala no diferencia qué tipo de adicción podría presentar el sujeto.

- Tampoco evalúa el consumo actual de sustancias.

- Los puntajes bajos (59 o <) no invalidan necesariamente la presencia de problemas de abuso. En general, este tipo de puntajes señala la probabilidad de abuso basado en una historia de desajuste psicológico más que el patrón típico de la conducta adictiva.

- Escala: AAS (Reconocimiento de adicción)

La escala de Reconocimiento de Adicción fue diseñada como una medida para evaluar la disposición de los sujetos a reconocer problemas de alcohol o drogas (Weed y cols., 1992). La escala está compuesta por 13 ítems que fueron derivados por una combinación de métodos racionales y estadísticos.

- Guía para la interpretación de los puntajes

- T 65 o >: el puntaje indica el reconocimiento de problemas serios de abuso de alcohol o drogas.

- T 60-64: el puntaje indica el reconocimiento de algunos problemas de abuso de alcohol o drogas.

- Las elevaciones en AAS indican la disposición y voluntad del sujeto para reconocer sus problemas pasados o presentes con las drogas.

- Los puntajes bajos (59 o <) no invalidan necesariamente la presencia de problemas de abuso de sustancias. Este tipo de puntaje sólo significa el no reconocimiento de conflictos en este sentido que puede corresponder a alguien que niega sus problemas o a quien no los presenta.

- Escala: MDS (Malestar matrimonial)

En los primeros estudios tendientes a diferenciar parejas que presentaban discordia o problemas respecto de las que no los tenían, se observó un comportamiento particular en la escala Pd que fue asociado con la discordia familiar (Butcher y Williams, 1992: 161). Más tarde esta escala fue diseñada seleccionando aquellos ítems que estuvieran significativamente asociados a problemas de este tipo. Las 14 frases incluyen contenidos que remiten al reconocimiento de problemas maritales o dificultad para las relaciones interpersonales.

— Guía para la interpretación de los puntajes

- La escala MDS sólo debe ser interpretada en sujetos casados, separados o, si amerita, divorciados.

- T 65 o >: el puntaje indica la probabilidad de tensión por problemas de relación marital.

- T 60-64: el puntaje indica la probabilidad de algunos problemas en la relación conyugal.

- Escala: O-H (Hostilidad excesivamente controlada)

Esta escala fue diseñada para identificar a personas que parecen tener dificultades para la expresión de la ira o el enojo, y que, en general, proceden de una manera sobrecontrolada como modo de domeñar conductas agresivas u hostiles (Megargee, Cook y Mendelsohn, 1967). Las personas que obtienen puntuaciones elevadas en esta escala tienden a guardar de modo rígido la expresión desembozada de la agresividad. A menudo, ante provocaciones extremas pueden reaccionar de manera violenta.

La escala O-H puede ser de utilidad para evaluar la presencia de características de personalidad asociadas a la tendencia a los actos violentos. Aun así, el carácter predictivo de la escala no es el mejor, ya que muchos sujetos que obtienen puntuaciones elevadas (T 65 o >) no presentan dificultades del control en un modo significativo. Sin embargo, puede ser usado como una medida de rasgos personales que influyen en la aparición de actos violentos.

- Guía para la interpretación de los puntajes

- T 65 o >: el puntaje no necesariamente implica potenciales conductas de acting-out. La interpretación debe rápidamente integrarse con otros datos para valorar con justeza los aumentos de la escala.

- La escala O-H es más valiosa como un indicador para explicar conductas que ocurrieron en el pasado que como una escala predictora del comportamiento futuro. La elevación de la escala también puede proveer información acerca de sujetos con antecedentes de conducta explosiva. Los aumentos de O-H en sujetos que han cometido crímenes violentos sugieren la posibilidad de emotividad constrictiva e ineficacia para expresar las emociones, y que pueden presentar estallidos de afecto cuando las defensas son sobrepasadas, dando lugar a una falla general en el control de la ira.

- Muchos individuos con aumentos en esta escala (por ejemplo, en selección de pilotos) son, sin embargo, adaptados socialmente y no presentan problemas en la expresión ni en el control impulsivo.

- Escala: Do (Dominancia)

La escala Do fue diseñada por Gough, McClosky y Meehl (1951) para evaluar características de personalidad en relación con las posiciones de dominio social. Para hacerlo, los autores definieron a sujetos con alta y baja dominancia indagando a pares o compañeros, quienes señalaban si eran predominante mente pasivos o dominantes en sus relaciones sociales. La escala Do, de 25 ítems en el MMPI-2, brinda información acerca de atributos como comodidad en las situaciones sociales, autoconfianza, opiniones firmes, perseverancia y capacidad de concentración. Las personas que presentan puntajes aumentados en la escala tienden a ser consideradas como dominantes en sus relaciones. Do suele ser especialmente evaluada en contextos de selección de policías o militares, ya que evalúa características que podrían interferir en un desempeño adecuado.

— Guía para la interpretación de los puntajes

- T 65 o >: el puntaje está asociado con los siguientes descriptores:

tendencia a ser dominantes en las relaciones sociales equilibrio emocional, seguridad en grupos

autoconfianza optimismo

orientado a la acción, actitud realista

enfoque adecuado para afrontar problemas actitud respetuosa para con los demás

- T 60-64: el puntaje indica personas probablemente con suficiente confianza en sí y que muestran iniciativa en situaciones interpersonales.

- Escala: Re (Responsabilidad social)

Esta escala fue desarrollada por Gough, McClosky y Meehl (1952) para evaluar el sentido de responsabilidad hacia los otros. Para ello contrastaron las apreciaciones dadas por pares y/o maestros respecto de a quiénes consideraban con responsabilidad alta o baja. La escala original contenía 32 ítems pero en la versión MMPI-2 está compuesta por 30. Las personas que obtienen aumentos en la escala se ven a sí mismas, y probablemente así son consideradas por los otros, como dispuestas a aceptar las consecuencias de su conducta. Se trata de sujetos seguros, confiables, íntegros y con sentido de la responsabilidad grupal. Las personas con puntuaciones disminuidas no se perciben como especialmente responsables de su accionar y pueden no aceptar valores o conductas consensuadas.

- Guía para la interpretación de los puntajes

- T 65 o >: los puntajes elevados están asociados a los siguientes descriptores:

valores aceptables y sostenidos

fuerte sentido de la justicia y de la propiedad altas normas a seguir

sentido de la responsabilidad de los demás autoconfianza

- T 60-64: estos puntajes sugieren la disposición del sujeto para aceptar las consecuencias de su accionar.

- Escala: PTSD (Estrés postraumático)

La escala PTSD fue diseñada para evaluar la presencia de sintomatología de estrés postraumático en militares veteranos de guerra (Keane, Malloy y Fairbank, 1984). La escala fue administrada a dos grupos: uno de veteranos con diagnóstico previo de VPSD y otro de veteranos con otros problemas psiquiátricos. Sus ítems diferenciaron correctamente a ambos grupos. Estudios posteriores (Litz y cols., 1991) muestran que la escala opera de la misma manera en el MMPI-2. La escala diseñada por Keane, Malloy y Fairbank (1984) aparece como PK en el perfil de las escalas suplementarias y allí se observa también una posterior, la escala PS, construida por Schlenger y cols. (1987 y 1989; tomado de Butcher y Williams, 1992:171). Ambas aparecen relacionadas con muchos índices de ansiedad tales como aumentos en Pt y en A. No sólo los veteranos de guerra sino también personas que experimentaron eventos catastróficos pueden obtener puntuaciones elevadas en esta escala. Los con tenidos incluyen ansiedad, depresión, disturbios del sueño, pensamientos intrusivos y sentimientos de ser incomprendidos o maltratados.

— Guía para la interpretación de los puntajes

- T 65 o >: estas puntuaciones suelen asociarse, con los siguientes descriptores:

sentimientos intensos de estrés emocional ansiedad, disturbios del sueño

sentimientos de culpa depresión

pensamientos perturbadores, intrusivos

probables experiencias de pérdida de control sobre el pensamiento

creencias de que son maltratados e incomprendidos

- Los puntajes elevados en PTSD no implican necesariamente que el sujeto ha padecido un trauma reciente. La presencia de éste debe ser establecida con el auxilio de otros métodos de evaluación antes de establecer el diagnóstico de trastorno por estrés pos- traumático.

- Escala: Es (Fuerza del yo)

La escala fue diseñada por Barron (1953) como una medida para valorar la disposición de los sujetos para beneficiarse de la experiencia psicoterapéutica. Fue desarrollada contrastando las respuestas de grupos de pacientes en psicoterapia con resultados exitosos y no exitosos. Gran parte de la investigación acerca de la escala sugiere que más que un predictor potencial de éxito terapéutico se trata de una medida para valorar la habilidad de resistir al estrés. En el MMPI-2 está compuesta por 52 ítems. El análisis de la escala debe realizarse con cautela, ya que es necesaria una mayor evidencia empírica para interpretarla en el sentido en el que la pensó su autor.

- Guía para la interpretación de los puntajes

- T 65 o >: estas puntuaciones sugieren la presencia probable de los siguientes descriptores: capacidad para afrontar situaciones de estrés ausencia de problemas psicológicos crónicos tolerancia, falta de prejuicios autoconfianza sagacidad, ingenio reconocimiento social intereses bien desarrollados buena responsividad a las psicoterapias verbales tolerancia a estrategias de confrontación en el tratamiento

- Escala: A (Ansiedad)

La escala fue construida por Welsh (1956) para evaluar el primer factor que emerge cuando las escalas básicas son analizadas factorialmente. Tanto en la versión original como en el MMPI-2, la escala consta de 39 ítems.

Los puntajes elevados en esta escala sugieren aflicción, ansiedad e inconformismo. Las personas que obtienen estas puntuaciones tienden a ser inhibidas y sobrecontroladas, con dificultades para tomar decisiones sin hesitación ni incertidumbre, ajustándose como pueden a las exigencias sociales.

En contraste, los puntajes bajos indican no reconocimiento de ansiedad y muchas veces reflejan a sujetos enérgicos, competitivos y extravertidos (Butcher y coautores, 1989: 37).

- Guía para la interpretación de los puntajes

- La escala A es un indicador del factor más robusto del MMPI-2, y está significativamente correlacionada con las escalas 7 y 8.

- T 65 o >: estas puntuaciones se asocian con sujetos que presentan las siguientes características:

- ansiedad

- desorganización y desajustes bajo situaciones de estrés escasa autoconfianza

- pesimismo

- timidez, retracción, inseguridad tiempos personales lentos

- Escala: R (Represión)

Esta escala fue derivada estadísticamente y representa el segundo factor más importante en el análisis factorial de los ítems del MMPI, e indica la presencia de conductas de sobrecontrol o de negación de conflictos. En el MMPI-2, la escala consta de 37 ítems.

Las puntuaciones elevadas señalan la probabilidad de emotividad constrictiva, poco espontánea e intensa. Es posible que se trate de sujetos pasivos y convencionales que evitan la confrontación en situaciones desagradables

o de displacer. En cambio, los puntajes bajos indican personas extravertidas, expresivas, desinhibidas y entusiastas (Butcher y coautores, 1989: 37).

- Guía para la interpretación de los puntajes

- La escala R es considerada como un indicador del segundo factor más consistente resultante del análisis factorial de los ítems del MMPI-2. Señala la probabilidad de sobrecontrol y se correlaciona con las escalas 2, L y K.

- T 65 o >: estas puntuaciones se encuentran asociadas a las siguientes características:

- sobrecontrol

- tendencia a la negación y a la racionalización

- actitud sumisa

- convencionalismo, conformismo

- enfoque cauteloso en su afrontamiento vital

- Escala: Mt (Inadaptación universitaria)

Esta escala fue desarrollada para discriminar entre aquellos estudiantes universitarios con una buena adaptación al ámbito de estudios de los que presentaban un ajuste dificultoso. La escala original contenía 43 ítems; en el MMPI-2 está compuesta por 41.

Los estudios indican que los puntajes obtenidos pueden utilizarse para identificar la probabilidad de conflictos emocionales entre estudiantes universitarios pero no para predecir dificultades de su adaptación futura.

- Guía para la interpretación de los puntajes

- T 65 o >: es probable la asociación con los siguientes descriptores:

sensación de ineficacia

pesimismo, ansiedad

- Escalas GM y GF (Roles y Géneros)

Estas dos escalas fueron diseñadas especialmente para el MMPI-2. Las escalas GM (Rol Masculino) y GF (Rol Femenino) se evalúan en hombres y en mujeres.

En la construcción de estas escalas se han empleado el mismo método que en las primeras investigaciones con el MMPI y el utilizado para las escalas de roles y géneros del CPI (California Psychological Inventory). Estos métodos contrastan con otros que son usados para el diseño de escalas basadas en el juicio clínico que enfocan únicamente atributos positivos, socialmente deseables.

La escala GM está compuesta por autodescripciones características de un género u otro suministradas por un conjunto particular de ítems.

Los ítems incluidos en la escala GM fueron aquellos marcados por la mayoría de la muestra de hombres y respondidos en la misma dirección por, como mínimo, un 10 % menos de mujeres.

Concomitantemente, los ítems incluidos en la escala GF fueron aquellos puntuados por la mayoría de las mujeres de la muestra y respondidos en la misma dirección por, como mínimo, un 10 % menos de hombres.

De los ítems propuestos, 47 reunieron los criterios para ser incluidos en la escala GM y 46 en la escala GF. Nueve de los ítems de la escala GM también aparecen para la escala 5 (Mf), así como también 16 de los 46 ítems de la escala GF.

La investigación preliminar de estas dos medidas (Butcher y coautores, 1989: 39) indican que, para temas masculinos, la escala GM se relaciona con autoconfianza, tenacidad y amplia gama de intereses, así como ausencia de miedos y sentimientos de autorreferencia.

Para las mujeres, la escala GM también está relacionada, con la autoconfianza, así como con la honestidad y la voluntad de probar nuevas cosas, y sin preocupaciones o sentimientos de autorreferencia.

De modo similar, para temas masculinos, la escala GF está relacionada con la religiosidad, con eludir los juramentos y las maldiciones, y la franqueza para señalar sus defectos a los otros.

Esta escala está también correlacionada con prepotencia y pobre control del temperamento, así como disposición al abuso de alcohol o drogas. Para las mujeres, GF también está vinculada a la religiosidad y problemas de abusos de sustancias.

Investigaciones futuras serán dedicadas al uso conjunto de estas escalas las cuales, probablemente, aportarán datos para distinguir patrones individuales en las mismas, que se oscurecerían si sólo una medida bipolar como la escala 5 fuera usada. Esto es, si una persona obtiene un puntaje alto, en una u otra de las escalas (GM/GF), bien podría ser identificada por un puntaje en un extremo o el otro de la escala 5; pero si alguien tiene alto o bajo puntaje en las dos, podría caer en los puntajes medios de la escala 5.